



Diário Clínico

Consulta Externa

12-Jul-2024 Dr(a). Ricardo M. Valente (HUC-CARDIOLOGIA)

Consulta programada FA permanente. AP: HTA longa data, DRC G3a, OA bilateral joelhos com limitação da marcha, DCL ligeiro; anemia normocítica ligeira em contexto renal. Internamento por PAC 12/2024, recuperado, sem sequelas respiratórias. Sem alergias conhecidas.

Globalmente estável. Nega palpitações sustentadas, dor torácica, síncope, ortopneia, DPN ou agravamento de edemas. Sem dispneia nova para o esforço habitual; limitação funcional predominantemente osteoarticular, mantém marcha curta com ritmo lento. Refere tontura postural episódica, breve, sobretudo ao levantar-se rapidamente, sem queda, lipotímia ou associação a palpitações; padrão antigo, sem agravamento. Sem hemorragia exteriorizada, hematúria, melena, epistaxis prolongada ou equimoses extensas sob hipocoagulação.

Mantém varfarina conforme esquema de INR e digoxina 0,125 mg id. Amlodipina 5 mg id, furosemida 20 mg id. Paracetamol SOS para gonalgias. Adesão aparentemente adequada; familiar confirma toma supervisionada parcialmente dada queixas mnésicas ligeiras, sem erro recente conhecido na anticoagulação.

EO: vigil, colaborante, discurso adequado, sem dificuldade respiratória em repouso. TA 128/68 mmHg sentado, 112/62 mmHg após ortostatismo, FC 72 bpm irregular, SatO2 97% ar ambiente, T 36,4 °C. AC com ritmo irregular, S1/S2 audíveis, sem sopros de novo; sem sinais clínicos de IC. AP sem crepitações, MV mantido bilateralmente. Sem edemas maleolares significativos; perfusão periférica conservada.

MCDTs: INR 2,54 em 08/07/2025, TP 28,1 s, dentro do alvo 2,0-3,0 para FA não valvular. Hb 11,4 g/dL, VGM 91 fL, leucócitos $6,8 \times 10^9/L$, plaquetas $184 \times 10^9/L$. Creatinina 1,38 mg/dL, ureia 54 mg/dL, TFGe 51 mL/min/1,73m², sem desvio relevante face a valores prévios conhecidos. Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Mg 2,0 mg/dL, Ca 9,1 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 17 U/L, bilirrubina total 0,7 mg/dL. TSH 2,16 mUI/L. Digoxinémia 0,72 ng/mL, em colheita pré-dose, intervalo compatível com terapêutica crónica e sem contexto clínico de toxicidade.

ECG de hoje, 12 derivações, com fibrilhação auricular mantida, atividade auricular desorganizada e ausência de ondas P identificáveis. Resposta ventricular média 70-75 bpm, intervalos RR variáveis, sem pausas superiores a 2 s no traçado registado. QRS estreito, 94 ms, eixo elétrico globalmente normal. Sem supradesnívelamento ou infradesnívelamento significativo de ST; ondas T discretamente achatadas em derivações laterais, sem alterações dinâmicas face a ECG de 01/2025. QTc estimado 420 ms. Sem critérios eletrocardiográficos de isquemia aguda ou de sobrecarga ventricular relevante.

Revisto ecocardiograma transtorácico de 03/2025. Ventriculo esquerdo não dilatado, diâmetro telediastólico 48 mm, espessuras parietais discretamente aumentadas em padrão concêntrico ligeiro. Função sistólica global preservada, FEVE biplano 58%, sem

Processado por computador - SClínico



Diário Clínico

Consulta Externa

alterações segmentares da contractilidade. AE moderadamente dilatada, volume indexado 43 mL/m², compatível com arritmia crónica; AD discretamente dilatada. Válvula aórtica esclerosada, sem estenose hemodinamicamente significativa, gradiente médio 7 mmHg; insuficiência mitral e tricúspide ligeiras. PSAP estimada 32 mmHg, sem evidência ecocardiográfica de HTP significativa. VCI de calibre normal e colapsável; sem derrame pericárdico. Sem alteração estrutural relevante comparativamente a exame de 2023.

FA permanente, controlo ventricular adequado e anticoagulação terapêutica. Sem sinais de descompensação cardiovascular. Manter varfarina no esquema atual, vigilância INR habitual pelo circuito assistencial; manter digoxina 0,125 mg id, sem indicação atual para ajuste. Reforçadas medidas posturais, hidratação prudente e levantar faseadamente; se agravamento das tonturas, queda, síncope ou FC baixa, antecipar reavaliação e ponderar revisão de furosemida/anti-hipertensor. Evitar AINEs e automedicação pelo risco hemorrágico/renal. Controlo Cardiologia em 9-12 meses, mais cedo se dispneia, edema, palpitações persistentes, hemorragia ou INR fora de alvo.

28-Jul-2024 Dr(a). Rui Valente (HUC-NEFROLOGIA)

Seguimento DRC G3a A1, provável etiologia hipertensiva/vascular. AP: HTA longa data, FA permanente hipocoagulada, gonartrose bilateral, DCL. Sem queixas urinárias, disúria, hematúria macroscópica ou dor lombar. Diurese preservada, sem noctúria relevante. Nega dispneia, ortopneia ou aumento ponderal recente. Sem edemas significativos. Tontura postural ocasional, sem síncope/quedas. Mantém autonomia com limitação sobretudo por gonalgia.

MH revista: varfarina conforme INR, digoxina 0,125 mg id, amlodipina 5 mg id, furosemida 20 mg id; paracetamol SOS. Sem AINEs. Reforçada evicção de ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, contrastes iodados não imprescindíveis e produtos de ervanária/suplementos sem validação.

EO: TA 132/68 mmHg, FC 72 bpm irregular, SpO₂ 97% AA, T 36,4°C, peso 73,1 kg, sem variação relevante. Eupneico. Mucosas hidratadas. Auscultação pulmonar sem fervores. AC arritmica, sem sopros evidentes. MMII sem edema depressível; pulsos periféricos palpáveis.

Analítica 22/07/2025: Hb 11,4 g/dL, Ht 34,6%, VGM 91 fL, leucócitos 6,8x10⁹/L, plaquetas 214x10⁹/L. Creatinina 1,42 mg/dL, TFGe CKD-EPI 49 mL/min/1,73m², versus Cr 1,39 mg/dL/TFGe 50 em 01/2025. Ureia 52 mg/dL. Na 140 mmol/L, K 4,5 mmol/L, Cl 104 mmol/L, HCO₃ 25 mmol/L, Ca 9,1 mg/dL, P 3,4 mg/dL, Mg 2,0 mg/dL. Albumina 4,0 g/dL. Glicemia 96 mg/dL. Ácido úrico 6,8 mg/dL. PTH intacta 78 pg/mL, 25-OH vitamina D 29 ng/mL. Urina II sem proteinúria, hematúria ou leucocitúria; densidade 1,015. RAC urinária 18 mg/g, sem albuminúria significativa.

Processado por computador - SClinico



Diário Clínico

Consulta Externa

Função renal globalmente estável, sem distúrbio hidroelectrolítico ou acidobásico. Anemia normocítica ligeira, estável, compatível com DRC; sem indicação atual para agente estimulador da eritropoiese. Manter terapêutica e controlo tensional. Adequada hidratação, evitar desidratação em contexto de doença intercorrente; ponderar suspensão transitória de diurético se perdas GI/febre, após contacto com médico assistente. Repetir hemograma, função renal, ionograma, bicarbonato, Ca/P/PTH, urina II e RAC em 6 meses. Reavaliação Nefrologia após análises.

05-Ago-2024 Dr(a). Ricardo Faria (HUC-ORTOPEDIA)

82A, seguimento por gonartrose bilateral, predomínio compartimento medial. AP: FA permanente hipocoagulada, HTA, DRC 3a, défice cognitivo ligeiro. Refere agravamento gradual da gonalgia mecânica bilateral, D>E, sem traumatismo/intercorrência. Dor à carga e após períodos de imobilidade, alguma rigidez matinal breve, sem tumefacção importante ou queixas inflamatórias. Redução progressiva do perímetro de marcha; actualmente cerca de 100-150 m, com necessidade ocasional de apoio externo. Dificuldade acrescida em escadas, levantar da cadeira e marcha em terreno irregular. Sem bloqueios francos; sensação ocasional de instabilidade, sem quedas recentes.

Faz paracetamol 1 g SOS, com alívio incompleto. Sob varfarina, pelo que evitados AINE sistémicos.

EO: TA 136/74 mmHg, FC 72 bpm irregular, SatO2 97% AA, T 36,4°C. Marcha lenta, antálgica, base discretamente alargada. Joelhos sem rubor/calor ou derrame apreciável. Discreta deformidade em varo bilateral, mais marcada à D. Dor à palpação das interlinhas mediais e crepitação femorotibial à mobilização. ADM aprox. 5-115° à D e 0-120° à E, dor terminal em flexão/extensão. Estabilidade ligamentar globalmente mantida; testes meniscais sem valorização. Sem défice neurovascular distal.

Rx joelhos bilateral, carga, AP/lateral e axial rotuliana: redução marcada do espaço femorotibial medial bilateral, assimétrica, mais expressiva no joelho direito. Osteófitos marginais femorais e tibiais nos compartimentos medial e lateral, de pequenas a moderadas dimensões, com entesopatia discreta da inserção quadricipital. Esclerose subcondral dos pratos tibiais mediais, sem geodes relevantes ou colapso ósseo. Compartimentos laterais relativamente preservados; articulações femoropatelares com alterações degenerativas ligeiras a moderadas, sem subluxação patelar. Sem fractura, lesão óssea focal ou derrame articular significativo. Comparativamente ao estudo de 2024, sem progressão imagiológica significativa. Aspecto compatível com gonartrose bilateral moderada-avançada, predominante medial.

Explicada evolução degenerativa e eventual indicação futura para artroplastia total do joelho, caso refractariedade a medidas conservadoras/incapacidade funcional marcada.

Processado por computador - SClinico



Diário Clínico

Consulta Externa

Para já, ponderação cirúrgica desfavorável pelo risco peri-operatório associado a FA sob anticoagulação, idade e DRC; manter vigilância e reavaliar após optimização clínica/cardiológica se necessário. Reforçar paracetamol 1 g até 8/8h SOS, máx. 3 g/dia; evitar AINE oral. Prescrita fisioterapia: analgesia, ganho/manutenção ADM, reforço quadrípedal/glúteo, treino proprioceptivo e marcha. Medidas de descarga ponderal/uso de bengala contralateral. Reavaliação em 4-6 meses ou mais cedo se agravamento.

10-Out-2024 Dr(a). Inês Valente (HUC-ORTOPEDIA)

4.ª sem. PO osteossíntese de fratura subcapital deslocada colo fémur D, 14/09/25. AP: FA sob hipocoagulação, DRC 3a, HTA, gonartrose bilateral. Em programa de reabilitação institucional. Refere dor mecânica inguinal/lateral coxa D de baixa intensidade, controlada com paracetamol SOS; sem dor nocturna importante. Carga parcial progressiva com andador, tolerada. Sem queda/intercorrências desde alta. Nega febre, calafrios, drenagem pela ferida, parestesias ou agravamento do edema.

EO: TA 132/74 mmHg, FC 76 bpm irregular, SatO2 97% AA, T 36,4°C. Marcha ainda antálgica, assistida por andador; transferência sentado-de-pé com apoio dos MS. Ferida operatória lateral D seca, bordos coaptados, sem eritema, calor, flutuação ou exsudado; agafos já removidos. Equimose residual peri-incisional em regressão. Dor ligeira à mobilização passiva terminal da anca, sem dor à carga axial suave. Mobilidade anca D: flexão ~85°, abd 25°, limitada por desconforto. Sem encurtamento/rotação anómala. Força distal preservada, sensibilidade e perfusão pé D mantidas. Sem edema significativo da perna, géméo indolor.

Rx bacia/anca D controlo, AP da bacia e axial da anca: redução da fratura do colo femoral mantida, sem desvio secundário nem varização. Material de osteossíntese em posição, sem sinais de migração, quebra, halo peri-implante ou penetração articular. Alinhamento cervicocefálico satisfatório. Traço fracturário ainda parcialmente identificável, com discreta esclerose das margens e início de formação de calo/ponte trabecular, compatível com consolidação em curso para o tempo pós-operatório. Sem colapso da cabeça femoral, sem alteração acetabular aguda. Partes moles sem coleções gasosas ou calcificações patológicas. Comparativamente ao controlo pós-operatório imediato, mantém estabilidade radiográfica global.

Manter carga parcial progressiva conforme tolerância e orientação Fisioterapia/Fisioterapia, com andador; evitar rotação forçada, impacto e quedas. Prosseguir treino marcha, transferências, mobilidade da anca e reforço muscular gradual. Analgesia com paracetamol SOS. Manter vigilância da anticoagulação/INR pelo circuito habitual. Reavaliação ortopédica em 4 sem., com Rx bacia/anca D; recorrer antes se dor crescente, incapacidade súbita de carga, febre ou alterações da ferida.



Diário Clínico

Consulta Externa

18-Nov-2024 Dr(a). Inês Valente (HUC-NEUROLOGIA)

Seguimento por DCL. Vem acompanhado por familiar. Mantém esquecimentos ocasionais, sobretudo nomes recentes, localização de objetos e recados não anotados; sem desorientação topográfica, erros de reconhecimento, episódios confusionais, alterações comportamentais ou flutuação cognitiva. Sem queixas de linguagem relevantes. Familiar sem perceção de agravamento desde última observação.

AIVD globalmente preservadas: continua a gerir conversas, telefone e rotina domiciliária habitual; supervisão pontual na organização de compromissos/medicação por esquecimentos prévios, sem erros com consequências. Limitação atual na mobilidade, compras e tarefas exteriores sobretudo condicionada por fratura colo fémur D operada em 09/2025, em recuperação funcional/seguimento Ortopedia. Sem perda cognitiva funcional associada. Sono sem fenómenos compatíveis com perturbação comportamental REM. Humor eutímico, sem apatia marcada, ansiedade incapacitante ou ideação depressiva.

AP: FA permanente sob varfarina e digoxina, HTA, DRC 3a, gonartrose bilateral, fratura colo fémur D pós-cirúrgica. Tonturas ortostáticas esporádicas, sem síncope ou queda recente não mecânica.

EO: TA 132/68 mmHg sentado, FC 72 bpm irregular, SpO2 97% ar ambiente, T 36,4°C. Vigil, colaborante, contacto adequado. Orientado auto e alopsiquicamente. Linguagem espontânea fluente, compreensão de ordens simples/complexas preservada, sem parafasias ou disartria. Pares cranianos sem assimetrias evidentes. Sem défice motor focal; marcha não valorizada por descarga parcial/auxiliar de marcha no contexto ortopédico recente.

Avaliação neuropsicológica de controlo revista. MMSE 27/30, equivalente ao previamente obtido, com perdas na evocação diferida e cálculo seriado; orientação temporal/espacial integral. MoCA 23/30, condicionado por recuperação espontânea reduzida de itens verbais, com benefício significativo por pistas semânticas e reconhecimento. Memória episódica verbal com aprendizagem inicial ligeiramente diminuída, curva de aquisição presente, evocação livre tardia abaixo do esperado para escolaridade; reconhecimento sem falsos positivos relevantes. Memória visual imediata e tardia dentro do limiar baixo-normal, sem padrão amnésico de armazenamento. Atenção sustentada, amplitude atencional e velocidade de processamento preservadas para idade. Funções executivas sem alterações clinicamente significativas: flexibilidade cognitiva, inibição e fluência fonémica adequadas. Nomeação por confrontação, compreensão, repetição e fluência semântica preservadas. Capacidades visuoespaciais/construtivas mantidas; cópia de figura complexa organizada, sem negligência. Sem alteração significativa face à avaliação de 02/2024; perfil compatível com compromisso ligeiro predominante mnésico, estável.



Diário Clínico

Consulta Externa

Sem critérios clínico-funcionais para perturbação neurocognitiva major. Sem indicação atual para inibidor da acetilcolinesterase ou memantina. Reforçadas medidas não farmacológicas: rotina estruturada, agenda/calendário visível, estimulação cognitiva regular, atividade física conforme reabilitação, controlo vascular e manutenção de interação social. Vigilância de agravamento mnésico, perda de autonomia, alterações neuropsiquiátricas ou desorientação. Reavaliação Neurologia e neuropsicologia em 12 meses, antecipar se deterioração funcional.

22-Dez-2024 Dr(a). Ricardo Valente (HUC-CARDIOLOGIA)

Reavaliação de FA permanente em contexto de pós-operatório recente de fractura subcapital fémur D, submetido a tratamento cirúrgico em 09/2025. AP: HTA longa data, DRC G3a, gonartrose bilateral avançada, défice cognitivo ligeiro, anemia normocítica crónica ligeira. Internamento por PAC 12/2024, sem sequelas respiratórias. Sem alergias conhecidas.

Refere boa evolução global desde alta ortopédica. Sem palpitações sustentadas, dor torácica, pré-síncope/síncope ou episódios de queda recentes. Nega dispneia em repouso, ortopneia, DPN, tosse ou expectoração. Sem edema periférico novo; refere discreto edema maleolar vespertino ocasional, habitual, com regressão nocturna. Tolerância ao esforço condicionada sobretudo por dor mecânica dos joelhos e recuperação funcional pós-fractura; marcha com apoio, sem queixas anginosas. Sem hemorragia exteriorizada sob varfarina: nega epistaxis, gengivorragia, hematúria, rectorragia/melena ou equimoses extensas. Episódios ocasionais de tontura postural, breves, sem relação evidente com palpitações; reforçadas medidas posturais/hidratação adequada. Esquecimentos esporádicos sem agravamento segundo familiar acompanhante, mantém autonomia parcial nas AVD.

MH confirmada: varfarina conforme esquema de anticoagulação, digoxina 0,125 mg id, amlodipina 5 mg id, furosemida 20 mg id, paracetamol SOS. Sem AINEs. Adesão aparentemente adequada; medicação organizada por familiar. Sem introdução recente de fármacos com interacção relevante com AVK.

EO: vigil, colaborante, eupneico em repouso. TA 132/68 mmHg, FC 72 bpm irregular, SpO2 97% AA, T 36,4°C. Peso 71,8 kg, sem variação ponderal significativa referida. AC: ritmo absolutamente irregular, S1 variável, sem sopros audíveis. AP: MV presente e simétrico, sem crepitações basais/sibilos. Sem turgência jugular. Membros inferiores sem edema franco, panturrilhas indolores.

INR venoso 2,48; TP 27,6 s, dentro do alvo terapêutico para FA não valvular. Hb 11,4 g/dL, Htc 34,8%, VGM 91 fL, leucócitos $6,9 \times 10^9/L$, plaquetas $214 \times 10^9/L$; anemia normocítica ligeira estável face a controlo anterior, sem trombocitopenia. Creat 1,38 mg/dL, eGFR CKD-

Processado por computador - SClínico



Diário Clínico

Consulta Externa

EPI 51 mL/min/1,73m², ureia 54 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Mg 2,0 mg/dL. AST 22 U/L, ALT 16 U/L, FA 103 U/L, bilirrubina total 0,7 mg/dL. NT-proBNP 684 pg/mL, valor compatível com FA/idade/DRC, sem incremento relevante face a doseamento prévio. Digoxinémia 0,7 ng/mL, colhida pré-toma, em intervalo terapêutico baixo; sem sinais clínicos ou electrocardiográficos de toxicidade.

ECG 12 derivações realizado em consulta, calibração 25 mm/s e 10 mm/mV. Fibrilhação auricular permanente, actividade fibrilatória de base, sem ondas P organizadas. Resposta ventricular média 70-75 bpm, intervalos RR variáveis, sem pausas superiores a 2 s no traçado obtido. QRS estreito, 92 ms, eixo eléctrico globalmente normal. Sem supradesnivelamento ou infradesnivelamento significativo do segmento ST; ondas T discretamente achatadas em derivações laterais, sem alterações isquémicas agudas. QTc aproximado 415 ms, interpretação limitada pela irregularidade do ritmo. Comparativamente ao ECG de 06/2025, mantém FA com frequência ventricular melhor controlada, sem alterações novas da repolarização ou critérios de sobrecarga ventricular.

Ecocardiograma transtorácico de 05/2025 revisto em processo: VE não dilatado, diâmetro telediastólico 49 mm, espessuras parietais discretamente aumentadas, compatíveis com remodelagem concêntrica ligeira em contexto hipertensivo. Função sistólica global preservada, FEVE biplano 58%, sem alterações segmentares da cinética. AE moderadamente dilatada, volume indexado 43 mL/m²; AD discretamente dilatada, achados concordantes com FA crónica. Válvula aórtica esclerótica, sem estenose hemodinamicamente significativa, gradiente médio 7 mmHg, insuficiência aórtica mínima. IM ligeira, IT ligeira; PSAP estimada 31 mmHg, sem evidência de HT pulmonar significativa. VD com dimensões e função sistólica preservadas, TAPSE 20 mm. Sem derrame pericárdico, VCI não dilatada e com colapso inspiratório mantido. Sem critérios ecocardiográficos de IC descompensada.

FA permanente, controlo de frequência adequado sob digoxina. CHA₂DS₂-VASc elevado por idade/HTA, mantendo indicação formal para anticoagulação; INR terapêutico e sem intercorrência hemorrágica. Sem sinais clínicos, analíticos ou electrocardiográficos de descompensação cardiovascular. Manter varfarina no esquema actual, vigilância INR conforme circuito habitual, alvo 2,0-3,0. Manter digoxina 0,125 mg id; reavaliar dose se deterioração da função renal, bradicardia, anorexia/náuseas ou sintomas neurológicos novos. Manter restante terapêutica. Evitar AINEs e automedicação, particularmente antibióticos/antifúngicos sem contacto prévio pela interferência com INR. Orientado para urgência se hemorragia, dispneia súbita, dor torácica, síncope ou FC persistentemente elevada. Consulta Cardiologia em 6 meses, com ECG, hemograma, função renal/ionograma, INR e digoxinémia prévia.

15-Fev-2024 Dr(a). Inês Valente (HUC-NEFROLOGIA)

Processado por computador - SClínico



Diário Clínico

Consulta Externa

AP: DRC G3a, HTA longa data, FA permanente sob hipocoagulação; anemia normocítica ligeira em contexto de DRC. Reavaliação após intercorrência respiratória/pneumonia em Janeiro, com agravamento transitório da função renal em contexto de infeção, menor ingestão hídrica e manutenção de diurético. Sem necessidade de TSR, sem algaliação. Refere recuperação clínica completa, apirexia, sem dispneia, vômitos ou diarreia. Apetite e hidratação entretanto normalizados. Diurese mantida, sem disúria, hematúria macroscópica, urgência ou diminuição sustentada do débito urinário. Sem edemas novos. Tontura postural ocasional ao levantar, sem síncope.

MH relevante: furosemida 20 mg id, amlodipina 5 mg id; varfarina ajustada a INR, digoxina 0,125 mg id. Evita AINEs; analgesia com paracetamol SOS para gonalgias.

EO: TA 132/68 mmHg sentado, FC 74 bpm irregular, SatO2 97% AA, T 36,4°C. Mucosas húmidas, sem sinais clínicos de desidratação. Eupneico em repouso, auscultação pulmonar sem crepitações. Sem edemas periféricos; sem dor à palpação lombar.

Analítica 12/02/26: Hb 11,3 g/dL, VGM 91 fL, leucócitos $6,8 \times 10^9/L$, plaquetas $214 \times 10^9/L$. Ureia 58 mg/dL, creatinina 1,42 mg/dL, TFG_e CKD-EPI 49 mL/min/1,73m²; valor próximo do basal habitual 1,35-1,45 mg/dL/TFG_e 47-52, após pico documentado em Janeiro de creatinina 2,08 mg/dL e ureia 91 mg/dL. Na 140 mmol/L, K 4,5 mmol/L, Cl 104 mmol/L, HCO₃ 25 mmol/L, Ca 9,1 mg/dL, P 3,4 mg/dL, Mg 2,0 mg/dL. Ácido úrico 6,7 mg/dL, albumina 3,9 g/dL. PCR 2,8 mg/L. Glicemia 96 mg/dL. PTHi 78 pg/mL, 25-OH vitamina D 29 ng/mL. Sumária urinária: densidade 1,015, pH 6,0, proteínas traço, sangue negativo, leucócitos negativo, nitritos negativo; sedimento sem hematúria, leucocitúria ou cilindros patológicos. RAC urinária 46 mg/g, proteinúria/creatininúria 0,14 g/g, sem proteinúria significativa.

Ecografia reno-vesical de Janeiro: rins de dimensões preservadas, D 10,1 cm e E 10,4 cm, discreto adelgaçamento cortical bilateral compatível com nefropatia crónica. Ecogenicidade cortical ligeiramente aumentada, sem assimetria relevante. Sem dilatação pielocalicial, cálculos ou massas renais. Quistos corticais simples milimétricos bilaterais, sem septos ou componentes sólidos. Bexiga moderadamente repleta, parede sem espessamento focal; sem resíduo pós-miccional significativo. Próstata discretamente aumentada, sem repercussão obstrutiva alta.

IRA pré-renal/infecciosa resolvida, função renal regressada praticamente ao basal de DRC G3a A2. Ionograma e equilíbrio ácido-base estáveis. Reforçadas hidratação regular, sobretudo em períodos febris, anorexia, perdas GI ou calor; evitar AINEs, contraste iodado não indispensável e automedicação. Em intercorrência com ingestão reduzida/perdas, contactar médico assistente para eventual suspensão transitória de furosemida e controlo precoce de creatinina/ionograma. Manter terapêutica atual sem alterações. Vigilância TA domiciliária e peso/edemas. Repetir função renal, ionograma, hemograma, urina II e RAC em 4-6 meses; antecipar se nova infeção ou redução da diurese.



Diário Clínico

Consulta Externa

10-Mar-2026 Dr(a). Ricardo M. Tavares (HUC-ORTOPEDIA)

6M pós osteossíntese de fx subcapital deslocada colo fémur Dt. Evolução favorável. Refere dor inguinal/anca Dt praticamente ausente em repouso, desconforto mecânico ligeiro apenas após marcha mais prolongada. Marcha progressivamente mais autónoma; mantém canadiana unilateral sobretudo exterior/terreno irregular, sem quedas recentes. Autonomia nas AVD melhorada. Sem dor nocturna, febre, rubor, drenagem ou outra intercorrência local. Queixas atuais predominantemente relacionadas com gonalgia bilateral mecânica conhecida, sem agravamento significativo.

AP: FA permanente sob varfarina, HTA, DRC G3a, gonartrose bilateral.

EO: TA 132/68 mmHg, FC 72 bpm irregular, SpO2 97% ar ambiente, T 36,4°C. Cicatriz lateral/proximal coxa Dt bem consolidada, seca, sem sinais inflamatórios, sem tumefação. Sem dor à palpação trocantérica ou inguinal. Mobilidade coxofemoral Dt: flexão ~105°, RI/RE conservadas e indolores; sem dor à carga axial. Força flexão/abdução 4+/5, sem défice neurovascular distal. Marcha com ligeira claudicação antálgica residual, compensada com canadiana; capacidade de carga total.

Rx bacia e anca Dt AP + perfil: material de osteossíntese do fémur proximal Dt em posição, sem migração, rotura ou sinais de afrouxamento peri-implante. Traço de fratura subcapital previamente identificado sem diástase residual, com continuidade trabecular e cortical completa na projeção disponível. Sem colapso cefálico, varização do colo ou perda de redução. Relação coxofemoral mantida, sem sinais de protrusão acetabular ou alteração degenerativa aguda. Discreta osteopenia difusa compatível com idade. Comparativamente ao controlo de Dez/2025, verifica-se progressão para consolidação completa, sem alteração da posição do implante. Sem evidência imagiológica de complicação mecânica ou infecciosa.

Consolidação clínica e radiológica completa. Alta da vigilância ortopédica dirigida a este episódio. Manter carga conforme tolerância, auxiliar de marcha por segurança enquanto necessário e programa de fortalecimento/treino de marcha. Seguimento habitual por gonartrose bilateral; reobservação se dor coxofemoral nova, perda funcional ou queda.

22-Abr-2026 Dr(a). Rui Faria (HUC-UROLOGIA)

82A. Seguimento HBP. AP: FA permanente hipocoagulada, DRC G3a, HTA, fragilidade ligeira; episódio de RAU em 2023, sem recorrência desde então. Queixas LUTS baixas, estáveis: jacto algo fraco, hesitação ocasional, noctúria 1-2x/noite. Sem urgência relevante, sem urge-incontinência, disúria, hematúria macroscópica ou dor



Diário Clínico

Consulta Externa

suprapúbica/perineal. Sensação de esvaziamento habitualmente completa. Sem ITU recente. Trânsito intestinal regular.

MH com varfarina conforme INR, digoxina 0,125 mg id, amlodipina 5 mg id, furosemida 20 mg id. Não medicado para HBP. Refere tolerar bem sintomatologia actual; sem interesse, de momento, em introdução de terapêutica dirigida.

EO: TA 132/68 mmHg, FC 72 bpm irregular, SatO2 97% AA, T 36,4°C. Abdómen flácido, indolor, sem globo vesical palpável. Genitais externos sem alterações relevantes. TR: próstata discretamente aumentada, estimada 35-40 g, elástica, superfície regular, sulco mediano mantido; sem nódulos, áreas pétreas ou dor à palpação.

Urina tipo II: densidade 1,015, pH 6,0, proteínas negativas, glicose negativa, nitritos negativos, esterases leucocitárias negativas, eritrócitos 0-2/campo, leucócitos 0-2/campo. Urocultura sem crescimento. Hb 11,6 g/dL, leucócitos $7,4 \times 10^9/L$, plaquetas $198 \times 10^9/L$. Creatinina 1,42 mg/dL, ureia 54 mg/dL, eTFG 49 mL/min/1,73m², valores sobreponíveis aos prévios. PSA total 2,18 ng/mL; PSA prévio 2,06 ng/mL em 04/2025, sem elevação significativa.

Ecografia reno-vesico-prostática: rins em topografia habitual, dimensões preservadas para a idade, diferenciação córtico-medular mantida. Sem litíase, massas focais ou dilatação pielocalicial bilateral. Bexiga moderadamente repleta, paredes sem espessamento focal ou lesões endoluminais identificáveis. Próstata com volume calculado de cerca de 38 cc, ecotextura heterogénea compatível com hiperplasia nodular, sem lesão suspeita. Resíduo pós-miccional 46 mL, sem significado obstrutivo major. Sem alterações relevantes face a ecografia prévia.

HBP com LUTS obstrutivos ligeiros, IPSS 7/35, QoL 2; sem RAU, ITU, hematúria, compromisso alto aparelho ou resíduo significativo. Manter atitude expectante/vigilância. Medidas comportamentais, micções programadas, reduzir ingestão hídrica vespertina/caféina. Reavaliar se agravamento; ponderar alfa-bloqueante se sintomas passarem a interferir funcionalmente, com prudência por tonturas posturais e terapêutica anti-hipertensora. Sem indicação cirúrgica actual. Controlo anual com PSA, função renal, urina II e ecografia; recorrer antes por impossibilidade miccional, hematúria ou febre.

18-Mai-2026 Dr(a). Rui Manuel Tavares (HUC-CARDIOLOGIA)

AP: FA permanente desde 2014, HTA longa data, DRC 3a, anemia normocítica ligeira associada a DRC, défice cognitivo ligeiro, OA joelhos bilateral; fractura colo fémur D pós-cirúrgica 09/2025, em reabilitação. Sem alergias conhecidas. Pneumonia 12/2024, resolvida. Sem novos episódios de queda, síncope ou hemorragia.



Diário Clínico

Consulta Externa

Consulta vigilância. Sem palpitações sustentadas, dor torácica, dispneia de esforço nova, ortopneia, DPN ou edema agravado. Tolerância ao esforço limitada sobretudo por gonalgia bilateral e recuperação funcional pós-fractura, sem limitação cardiorrespiratória referida. Deambula com apoio exterior; sem quedas recentes. Tontura postural ocasional ao levantar, breve, sem lipotímia; reforçadas medidas posturais/hidratação adequada, atendendo a diurético e fragilidade. Sem queixas hemorrágicas sob ACO: nega epistáxis, gengivorragia, hematúria, melena ou hematomas espontâneos extensos. Sem agravamento cognitivo referido por acompanhante.

MH: varfarina conforme esquema de INR, digoxina 0,125 mg id, amlodipina 5 mg id, furosemida 20 mg id, paracetamol SOS. Boa adesão global, sem toma de AINEs. Mantém controlo de INR em unidade habitual.

EO: vigil, colaborante, eupneico em repouso. TA 132/68 mmHg, FC 72 bpm irregular, SpO2 97% ar ambiente, T 36,4 °C. Peso 71,8 kg, sem variação ponderal significativa referida. AC com ritmo irregular, S1/S2 audíveis, sem sopros significativos. AP sem crepitações, MV mantido bilateralmente. Sem ingurgitamento jugular; membros inferiores sem edema maleolar relevante.

ECG 12 derivações efectuado hoje: fibrilhação auricular permanente, resposta ventricular controlada, FC média 70-75 bpm. QRS estreito, 92 ms, eixo eléctrico globalmente normal, sem bloqueio de ramo. Sem ondas Q patológicas recentes. Segmentos ST sem desvios significativos, ondas T sem alterações isquémicas agudas. QTc estimado 412 ms, sem prolongamento relevante. Traçado sobreponível ao ECG de 11/2025, sem evidência electrocardiográfica de isquemia aguda ou nova perturbação da condução.

Analítica de 14/05/2026: Hb 11,4 g/dL, Ht 34,8%, VGM 91 fL, leucócitos $6,7 \times 10^9/L$, plaquetas $196 \times 10^9/L$. INR 2,46, TP 28,1 s, dentro do alvo terapêutico para FA. Creatinina 1,38 mg/dL, ureia 52 mg/dL, TFGe CKD-EPI 51 mL/min/1,73m², sem agravamento face a valores prévios conhecidos. Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Mg 0,86 mmol/L, Ca 9,1 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 17 U/L, FA 89 U/L, bilirrubina total 0,7 mg/dL. Glicemia 96 mg/dL. NT-proBNP 684 pg/mL, valor compatível com FA/idade e sem incremento relevante face a determinação anterior. Digoxinémia 0,72 ng/mL, em intervalo terapêutico baixo, sem clínica sugestiva de toxicidade.

Ecocardiograma transtorácico de controlo de 15/05/2026 com qualidade técnica aceitável. AE moderadamente dilatada, volume indexado 43 mL/m², contexto de FA crónica; AD discretamente dilatada. VE não dilatado, diâmetro telediastólico 48 mm, espessuras parietais com hipertrofia concêntrica ligeira. Função sistólica global preservada, FEVE biplano 58%, sem alterações segmentares da contractilidade. Padrão de avaliação diastólica limitado pela FA, sem sinais indirectos de elevação marcada das pressões de enchimento. Válvula aórtica trivalvular com esclerose ligeira, sem estenose hemodinamicamente significativa; gradiente médio 7 mmHg, insuficiência aórtica mínima.



Diário Clínico

Consulta Externa

Insuficiência mitral ligeira e tricúspide ligeira, PSAP estimada 31 mmHg. VD com dimensões e função sistólica preservadas, TAPSE 20 mm. Sem derrame pericárdico. Globalmente sem alterações estruturais significativas face ao estudo de 05/2025.

25-Jun-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-NEUROLOGIA)

Seguimento DCL. Acompanhante confirma estabilidade global desde última observação; esquecimentos ocasionais de nomes/recados, sem desorientação topográfica, erros de reconhecimento familiar ou alterações comportamentais. Mantém gestão das rotinas simples e participação nas decisões domésticas; filha supervisiona medicação/questões financeiras por precaução, sem perda funcional nova. Sem alucinações, flutuações cognitivas, perturbação marcada do sono REM ou quedas recentes. Marcha mais lenta, condicionada por gonartrose bilateral e pós-operatório de fratura colo fémur D, sem agravamento neurológico focal.

AP: FA permanente anticoagulada, HTA, DRC 3a, gonartrose bilateral, fratura colo fémur D operada 09/2025. MH inclui varfarina conforme INR e digoxina 0,125 mg id.

EO: TA 134/72 mmHg, FC 68 bpm irregular, SpO2 97% AA, T 36,4°C. Vigil, colaborante, discurso fluente e adequado ao contexto. Orientado auto e alopsiquicamente; evocação diferida discretamente diminuída, melhora com pistas semânticas. Atenção sustentada preservada. Sem apraxia, afasia ou negligência. Pares cranianos sem alterações; força global 5/5, sem défice piramidal. Marcha de base ligeiramente alargada, antálgica, com apoio de canadiana; sem instabilidade marcada.

MoCA 23/30, escolaridade considerada: falhas em evocação livre 3/5, fluência verbal e desenho do cubo; orientação 6/6. Sem declínio significativo face a 24/30 em 02/2025. Hemograma com Hb 11,7 g/dL, VGM 91 fL, leucócitos $6,8 \times 10^9/L$, plaquetas $212 \times 10^9/L$. Creatinina 1,34 mg/dL, TFG 52 mL/min/1,73m², ureia 48 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Ca 9,2 mg/dL. TSH 2,08 mUI/L, vitamina B12 418 pg/mL, ácido fólico 10,6 ng/mL.

TC-CE 05/2026 sem lesão expansiva, hemorragia ou sinais de isquemia recente. Discreta atrofia cortical difusa, sem predomínio temporo-mesial significativo para idade. Hipodensidades periventriculares e da substância branca profunda ligeiras, compatíveis com microangiopatia crónica. Sistema ventricular sem hidrocefalia. Sem alteração estrutural relevante comparativamente a 2024.

Mantém critérios de DCL, sem evidência atual de conversão demencial. Reforçada estimulação cognitiva regular, contacto social e exercício adaptado/fisioterapia, atendendo à limitação osteoarticular. Controlo rigoroso de fatores vasculares. Sem indicação para terapêutica procognitiva nesta fase. Reavaliação em 12 meses, antecipar se declínio funcional, alterações comportamentais ou agravamento cognitivo.